Fugue et disparition

FICHE SOCLE DOTR
VERSION 1
Mise à jour : Octobre 2026

Prévenir sans enfermer, fiche signalétique, alerter sans attendre, signaler, examiner au retour.
EHPAD · MAS · FAM · EAM · IME · IEM — médecin coordonnateur / d'établissement, direction, IDEC

À RETENIR

L'absence inexpliquée d'une personne vulnérable est une urgence : recherche immédiate, puis 17 ou 112 sans attendre. Aucun délai légal de 24 h. La fiche signalétique se prépare avant la disparition, pas pendant.

Sources : Code de procédure pénale, art. 74-1 · proposition DOTR

PRÉVENIR SANS ENFERMER

- **Liberté d'aller et venir** garantie (L311-3 1°) : toute restriction est individuelle, nécessaire, proportionnée, jamais punitive.
- **EHPAD** : mesures inscrites dans l'**annexe au contrat de séjour**, après examen et évaluation pluridisciplinaire à l'initiative du MedCo ; réévaluées au moins tous les 6 mois (R311-0-7, R311-0-9).
- Urgence : mesures provisoires strictement nécessaires par le MedCo et le directeur (R311-0-8).
- **Handicap, IME** : risque évalué dans le **projet personnalisé** (déclencheurs, lieux habituels, signes d'alerte).
- Rechercher une cause au besoin de partir : douleur, confusion, angoisse, iatrogénie (proposition DOTR).

Sources : CASF L311-3, L311-4-1, R311-0-6 à R311-0-9 · ANAES/FHF, conférence de consensus « Liberté d'aller et venir… » (11/2004)

FICHE SIGNALÉTIQUE, PRÉPARÉE À L'AVANCE

Une fiche par personne à risque, rangée avec le DLU, mise à jour chaque année et après tout changement d'apparence.

Photo récente (date) : .....

Taille, corpulence, signes distinctifs : .....

Tenue, chaussures, aide à la marche : .....

Communication, traitement vital, allergies : .....

Lieux habituels, anciennes adresses : .....

Personnes à prévenir (famille, tuteur) : .....

Sources : Proposition DOTR · photo : consentement au droit à l'image recueilli à l'admission

ALERTER : LES PREMIÈRES MINUTES

- Recherche immédiate et organisée du bâtiment et des abords : fiche AS « Personne introuvable (fugue, disparition) ».
- **17 ou 112** dès que la recherche immédiate est vaine ; d'emblée si nuit, froid, chaleur, traitement vital ou propos suicidaires.
- **Pas de délai d'attente** : l'enquête est possible dès que la disparition « vient d'intervenir ou d'être constatée » (mineur, majeur protégé, majeur vulnérable par l'âge ou l'état de santé).
- Remettre la fiche signalétique, l'heure de dernière vue et les **risques médicaux** (insuline, antiépileptique, O2, troubles cognitifs).
- Personne retrouvée en détresse : **15**.

Sources : Code de procédure pénale, art. 74-1 · proposition DOTR

INFORMER ET SIGNALER

- **Famille**, personne de confiance, **représentant légal** ; mineur : titulaires de l'autorité parentale, ASE si l'enfant lui est confié. Par la direction ou le cadre.
- **Direction** : signalement « disparition » sans délai à l'autorité (ARS et/ou conseil départemental) **dès que police ou gendarmerie sont alertées** ; confirmation écrite sous 48 h si l'alerte est orale ; sans donnée nominative.
- Retour : prévenir police, famille et autorité ; CVS avisé.
- Médecin coordonnateur ou d'établissement informé dès l'alerte.

Sources : CASF L331-8-1, R331-8, R331-10 · arrêté du 28/12/2016, art. 1, 9° · fiche socle « Qui signale quoi, à qui ? »

AU RETOUR : EXAMEN MÉDICAL

- Accueil calme, sans reproche ni contention.
- **Examen** (IDE puis médecin) : traumatisme, T° (hypo- ou hyperthermie), hydratation, glycémie si diabète, pieds, peau, **signes de violence**, confusion (cause organique ?).
- Traitements manqués : fiche AS « Oubli de traitement » ; reprise sur avis médical.
- Tout tracer : heures, recherches, alertes, examen.

Sources : Proposition DOTR

APRÈS : ANALYSER, AJUSTER

- **Analyse en équipe** dans les jours qui suivent : cause, circonstances, surveillance, environnement ; déclaration interne.
- Réviser le **projet personnalisé** ou l'**annexe au contrat de séjour**, sans restriction disproportionnée en réaction.
- Fugues répétées d'un adolescent (IME) : travail avec la famille et le projet ; appui extérieur si besoin.

Sources : CASF R311-0-9 · HAS, référentiel d'évaluation de la qualité des ESSMS (gestion des événements indésirables) · proposition DOTR

MÉDECIN DOTR

Pendant l'absence : évalue le risque médical (traitement vital, froid, chaleur) pour l'IDE, la direction et les forces de l'ordre. Au retour : examen en téléconsultation avec l'IDE, photos des lésions par HEALPHI ; si gravité → 15. Participe à l'analyse et à la révision du projet.

Sources : Proposition DOTR

Fiche DOTR, à adapter avec le médecin coordonnateur ou le médecin de l'établissement. Les mentions « proposition DOTR » ne viennent pas d'un texte. Ne remplace ni les procédures de l'établissement ni l'avis médical.

VMS Vision Moderne de la Santé
Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.